



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde

Ofício SMS nº 13469/2026

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2026

Assunto: Esclarecimentos sobre a orientação de reutilização de seringas de insulina por usuários no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro

A Superintendência de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (S/SUBPAV/SAP) vem a público prestar esclarecimentos sobre a orientação emitida no Ofício SMS nº 11961/2026, que instrui, em caráter excepcional, a reutilização de seringas de insulina por até 3 vezes, por usuários da rede municipal, em razão de situação de contingência no abastecimento deste insumo.

Dentre as justificativas que subsidiam esta orientação, encontram-se: o cenário de desabastecimento, a segurança clínica embasada em evidências e os protocolos de utilização vigentes.

1. O CONTEXTO DO DESABASTECIMENTO DE SERINGAS DE INSULINA

O município do Rio de Janeiro encontra-se em uma situação de desabastecimento de seringas de insulina decorrente de uma série de fatores, destacando-se alguns abaixo:

1.1 Fornecimento insuficiente de canetas aplicadoras de insulina pelo Ministério da Saúde desde 2022

Em 2019, teve início a dispensação das canetas aplicadoras de insulina humana NPH (Insulina Humana NPH 100 UI/ml, tubete de 3 ml), insulina humana regular (Insulina Humana Regular 100 UI/ml, tubete de 3 ml), conforme critérios estabelecidos na Nota Técnica N° 204/2019-CGAFB/DAF/SCTIE/MS (BRASIL, 2019).

Em 2022, o MS ampliou a faixa etária para uso de canetas através da Nota Técnica n° 169/2022-CGAFB/DAF/SCTIE/MS (BRASIL, 2022), que atualiza a Nota Técnica n° 84/2021 e que estabeleceu como público-alvo usuários em uso de insulina, com Diabetes Mellitus tipo 1 ou 2, na faixa etária menor ou igual a 19 anos e maior ou igual a 45 anos.

No entanto, o município do Rio de Janeiro já havia feito a substituição de frascos para canetas de insulina, atendendo à proporção de 70% do consumo com frascos de 10 mL e 30% com canetas/tubetes de 3 mL, conforme critérios estabelecidos pelo MS, e não foi possível a ampliação para a faixa etária sugerida, mantendo-se a distribuição para as pessoas com 19 anos ou menos e para as pessoas com 50 anos ou mais.

Em 26 de agosto de 2024, por meio do OFÍCIO CIRCULAR N° 26/2024/CGAFB/DAF/SECTICS/MS (BRASIL, 2024), o MS informou sobre a descontinuação temporária da fabricação dos frascos de insulina humana NPH e regular pela empresa Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil LTDA, sinalizando possível cenário de desabastecimento nacional.

Para mitigação desse cenário, o MS celebrou contratos para fornecimento de insulinas em frascos e em carpules, com utilização de canetas. No entanto, ao longo de 2024 e 2025, ocorreram atrasos e fragmentação nas entregas, impactando diretamente na regularidade

do abastecimento no município do Rio de Janeiro.

A partir de março de 2025, teve início a transição do modelo de canetas pré-carregadas para canetas reutilizáveis com carpules. Ressalta-se que a primeira remessa de canetas reutilizáveis foi insuficiente para atender a totalidade dos usuários previamente em uso de canetas pré-carregadas, resultando na necessidade de distribuição simultânea de diferentes apresentações de insulina, o que gerou significativa complexidade logística na rede municipal.

Mesmo após diversas solicitações de aumento de aporte de canetas, o município segue insuficientemente contemplado em sua necessidade.

Em agravo ao fornecimento insuficiente, em junho de 2025, foi sinalizado à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) que 3102 unidades de canetas reutilizáveis recebidas tiveram seu uso condenado por fragilidades e, até o momento, não foram repostas.

Diante da insuficiência de canetas reutilizáveis, a Superintendência de Atenção Primária, em 29 de agosto de 2025, por meio do Ofício nº SMS-OFI-2025/34325, orientou o uso de seringas de insulina para aspiração dos tubetes e aplicação do medicamento.

Em estudo realizado pela Gerência da Assistência Farmacêutica em março de 2026 (S/IVISA/CTATS/GAF), o déficit atual de canetas é de 47.925 unidades, quantitativo reportado oficialmente à SES/RJ, com o objetivo de ampliar o fornecimento.

Até o momento a SMSRJ segue sem o recebimento suficiente de canetas reutilizáveis, com aumento da demanda por seringas, que está totalmente previsto e seguro do ponto de vista de disponibilidade orçamentária para aquisição deste insumo.

1.2 Não entrega de seringas pelos fornecedores contratados

No que tange à disponibilidade de seringas de insulina, cumpre registrar que a Secretaria Municipal de Saúde detém Atas de Registro de Preços, as quais perfazem o quantitativo de 8.000.000 de seringas de insulina, distribuídas equitativamente entre as apresentações de 50 UI e 100 UI. Adicionalmente, foi integralmente remanejado e direcionado à Atenção Primária à Saúde (APS) por meio de uma ata sob gestão da Subsecretaria Hospitalar de Urgência e Emergência, um saldo remanescente de 1.687.000 unidades, visando garantir a continuidade da dispensação às pessoas com diabetes assistidas pela rede.

Contudo, a despeito do planejamento administrativo e dos sucessivos pedidos de compra formalizados por esta Secretaria, as empresas detentoras das atas vêm reportando obstáculos significativos no cumprimento dos prazos, justificando a irregularidade nas entregas com base em um cenário de desabastecimento global e escassez de matéria-prima. Tais fornecedoras alegam que a falta de insumos no mercado é agravada pela escassez de derivados do petróleo e pelas dificuldades logísticas junto aos fabricantes primários, impedindo o pleno atendimento da demanda.

Nesse contexto, esta Secretaria tem envidado esforços exaustivos para mitigar os impactos do desabastecimento, promovendo sucessivas reuniões de negociação com as empresas detentoras das atas e estabelecendo cronogramas de entregas que, sistematicamente, não vêm sendo honrados pelos fornecedores. No intuito de viabilizar o suprimento da rede, a Administração Pública procedeu, inclusive, à flexibilização para a troca de marcas e fabricantes das seringas, buscando alternativas que pudessem acelerar o recebimento dos itens, contudo, mesmo diante de tais concessões e das intensas tratativas administrativas, as empresas contratadas permanecem em situação de inadimplência.

É importante salientar que, desde janeiro do ano corrente, a SMSRJ empenhou mais de 9 milhões de seringas de insulina com 4 empresas diferentes, das quais apenas 1 milhão foi entregue.

Do ponto de vista sancionatório, é imperativo destacar que o descumprimento injustificado das obrigações assumidas enseja a abertura de processos administrativos punitivos. Tais procedimentos podem culminar em sanções gravosas, incluindo a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública em âmbito nacional, conforme preceitua a legislação vigente.

Em decorrência do recorrente atraso na entrega das seringas de insulina e da persistente inexecução dos cronogramas pactuados, esta Secretaria formalizou a instauração de processo administrativo sancionatório em face da empresa **PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, autuado sob o **SEI nº 0900.034714/2026-15**. A abertura de tal procedimento encontra-se devidamente

conferida mediante publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, datada de 16 de abril de 2026, especificamente na página 79, 2ª coluna, visando à apuração das responsabilidades contratuais e à eventual aplicação das penalidades previstas na legislação vigente (<https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/14764#/p:79/e:14764?find=prohosp>).

Diante da convergência desses fatores e da impossibilidade de interrupção da insulinoterapia — que pode levar a cetoacidose diabética, coma e óbito —, esta Secretaria emitiu orientação para **reutilização limitada e criteriosa das seringas** disponíveis. Os dados abaixo evidenciam a magnitude do descompasso entre empenho e entrega efetiva.

Quadro 1: Empenhos de seringas de insulina emitidos e enviados às empresas pela SMSRJ

DATA DE ENVIO DO EMPENHO	EMPENHO	QUANTIDADE	VALOR	ITEM	QUANT. ENTREGUE	QUANT. PENDENTE
27/08/25	2025NE002425 (Prohosp)	500.000	R\$ 100.000,00	SERINGA, DESCARTAVEL INSULINA 0,5ML(50UI)COM AGULHA FIXA (INTEGRADA)	102.000 (em 06/10/25)	399.000 (entregue somente em 01/2026 com o empenho 2026NE000452)
27/11/25	2025NE002870 (Prohosp)	500.000	R\$ 100.000,00	SERINGA, DESCARTAVEL INSULINA 0,5ML(50UI)COM AGULHA FIXA (INTEGRADA)	500.000 seringas 100 UI (em 17/12/2025)	-
16/01/2026	2026NE000452 (Prohosp)	399.000	R\$ 79.800,00	SERINGA, DESCARTAVEL INSULINA 0,5ML(50UI)COM AGULHA FIXA (INTEGRADA)	399.000 (em 22/01/2026)	-
16/01/2026		50.000	R\$ 10.000,00	SERINGA,DESCARTAVEL INSULINA 1ML(100UI)AGULHA FIXA(INTEGRADA)6MMX0,25	50.000 (em 22/01/2026)	-
06/02/26	2026NE000379 (Prohosp)	500.000	R\$ 100.000,00	SERINGA, DESCARTAVEL INSULINA 0,5ML(50UI)COM AGULHA FIXA (INTEGRADA)	500.000 (em 02/03/2026)	-
06/02/26	2026NE000377 (Prohosp) (EM ATRASO)	3.530.008	R\$ 706.001,60	SERINGA,DESCARTAVEL INSULINA 1ML(100UI)AGULHA FIXA(INTEGRADA)6MMX0,25	0	3.530.008
09/03/26	2026NE000733 (Prohosp) (EM ATRASO)	2.099.000	R\$ 419.800,00	SERINGA, DESCARTÁVEL INSULINA 0,5ML(50UI) COM AGULHA FIXA (INTEGRADA).	0	2.099.000
25/03/26	2026NE000782 (Nova linea) (EM ATRASO)	433.444	R\$ 91.023,24	SERINGA, DESCARTAVEL INSULINA 0,5ML(50UI)COM AGULHA FIXA (INTEGRADA)	0	433.444
25/03/26	2026NE000783 (Roma) (EM ATRASO)	66.231	R\$ 17.220,06	SERINGA, DESCARTAVEL INSULINA 0,5ML(50UI)COM AGULHA FIXA (INTEGRADA)	0	66.231
25/03/26	2026NE000784 (Nova linea) (EM ATRASO)	1.187.326	R\$ 237.465,20	SERINGA,DESCARTAVEL INSULINA 1ML(100UI)AGULHA FIXA(INTEGRADA)6MMX0,25	51.000 (em 15/04/2026)	1.187.326
14/04/2026	2026NE001085Med Lagos	400.000	R\$ 96.000,00	SERINGA, DESCARTAVEL INSULINA 0,5ML(50UI)COM AGULHA FIXA (INTEGRADA)	-	400.000

14/04/2026	2026NE001086Med Lagos	400.000	R\$ 96.000,00	SERINGA,DESCARTAVEL INSULINA 1ML(100UI)AGULHA FIXA(INTEGRADA)6MMX0,25	-	400.000
------------	--------------------------	---------	------------------	--	---	---------

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira, Orçamentária e Contábil da Prefeitura do Rio de Janeiro - SIAFIC

2. PROTOCOLOS PARA INSULINOTERAPIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

A orientação de reutilização está em plena conformidade com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 2 (PCDT DM2) do Ministério da Saúde, atualizado pela **Portaria SCTIE/MS nº 13, de 21 de fevereiro de 2026**, que mantém a orientação de que o reuso de seringas e agulhas de insulina por um número limitado de vezes pode ser considerado, devendo ser substituídas quando a pessoa notar aumento na sensação de dor, o que se estima que aconteça em **até oito utilizações**.

A orientação desta Secretaria — de reutilização em **até 3 vezes** — é significativamente mais restritiva que o limite de 8 utilizações previsto no PCDT.

A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda a reutilização de insumos por até três aplicações no mesmo dia, diretriz incorporada ao Guia Rápido de Diabetes da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Entretanto, considerando que a maioria dos usuários realiza apenas uma aplicação diária, geralmente no período noturno, tal orientação se mostra insuficiente para assegurar a adequada cobertura de estoque. Ressalta-se que a reutilização em dias distintos encontra respaldo no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde de 2025, bem como em diretrizes internacionais e na literatura científica vigente.

3. A CLASSIFICAÇÃO REGULATÓRIA DA ANVISA E O USO DOMICILIAR

É importante esclarecer que a classificação de seringas de insulina como “produto de uso único” pela ANVISA não configura proibição da reutilização pelo próprio usuário em domicílio. Essa classificação resulta de uma cadeia normativa industrial: a norma internacional ISO 8537 define o produto como “sterile single-use syringe”; a ABNT a adotou como NBR ISO 8537; e a ANVISA construiu seu regulamento de registro (RDC nº 3/2011, atualizada pela RDC 341/2020) referenciando essa norma, oferecendo ao fabricante apenas categorias de registro que já trazem “uso único” no nome — não existindo categoria de seringa de insulina reutilizável no sistema regulatório brasileiro.

A inclusão de seringas plásticas na lista de reprocessamento proibido (RE nº 2.605/2006) opera dentro de um arcabouço voltado ao reprocessamento institucional em serviços de saúde (conforme RE nº 2.606/2006 e RDC nº 156/2006, Art. 9º). Em nenhum ponto dessa cadeia normativa — da ISO à RE 2.605 — há registro de avaliação clínica sobre os riscos específicos da reutilização domiciliar pelo mesmo usuário. Essa lacuna regulatória é evidenciada pelo próprio PCDT do Ministério da Saúde, que autoriza a reutilização no mesmo documento em que referencia as normas da ANVISA.

4. RESPALDO DA COMUNIDADE CIENTÍFICA INTERNACIONAL

A American Diabetes Association (ADA), em seus *Standards of Care in Diabetes* — edições 2025 e 2026 (publicados no *Diabetes Care*) —, afirma que seringas de insulina são geralmente usadas uma vez, mas **podem ser reutilizadas pelo mesmo indivíduo em cenários de recursos limitados**, com armazenamento e higiene adequados (Seção 7: Diabetes Technology).

O FITTER Forward (*Mayo Clinic Proceedings*, 2025), documento de referência internacional elaborado por 16 especialistas de 13 países, reconhece igualmente que, diante de limitações práticas, reutilizar a própria agulha pode ser preferível a perder uma aplicação de insulina.

5. EVIDÊNCIAS SOBRE SEGURANÇA

A única revisão sistemática com meta-análise disponível sobre o tema (Zabaleta-Del-Olmo et al., *International Journal of Nursing Studies*, 2016;60:121-132), que analisou 25 estudos, concluiu que não há evidência científica clara para recomendar contra a reutilização de agulhas para injeção subcutânea de insulina. Especificamente:

(a) Infecção no local de injeção: meta-análise de 5 estudos não encontrou associação entre reutilização e infecção local (diferença de risco = -0,00; IC 95%: -0,12 a 0,11; P = 0,99).

(b) Controle glicêmico: dados agrupados não mostraram associação entre reutilização e piora da HbA1c.

(c) Integridade da agulha e dor: a meta-análise de 2 estudos transversais demonstrou maior percepção de dor entre reutilizadores crônicos (diferença de risco = 0,24; IC 95%: 0,06–0,43; P = 0,006). Entretanto, estudo prospectivo controlado com avaliação cega (Puder et al., *Diabetes Research and Clinical Practice*, 2005;67:119-123) não encontrou aumento de dor com até 4–5 reutilizações em condições padronizadas, sugerindo que o aumento de dor observado nos estudos transversais pode estar associado à reutilização excessiva (>5 vezes). O PCDT do Ministério da Saúde orienta a substituição da seringa quando o usuário notar aumento na sensação de dor, o que se estima que aconteça em até oito utilizações. O limite de 3 reutilizações adotado por esta Secretaria situa-se abaixo do limiar em que o aumento de dor foi documentado.

(d) Lipo-hipertrofia: este é o único risco consistentemente documentado, associado sobretudo à reutilização frequente (≥5 vezes por agulha). Meta-análise de 51 estudos citada na Diretriz SBD 2025 demonstra que o principal fator de risco para lipo-hipertrofia é o rodízio incorreto dos locais de aplicação (OR 8,85), sendo este um fator quase três vezes mais importante que a reutilização de agulhas (OR 3,20). Esse risco é prevenível com rodízio adequado dos locais, conforme orientado nas recomendações emitidas aos profissionais e usuários da rede.

6. ORIENTAÇÕES AOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS

Em decorrência da situação de contingência, e em conformidade com as referências acima, orientamos:

- Reutilizar a seringa em até 3 vezes no total (3 aplicações por seringa), pela mesma pessoa;
- Reencapar a agulha após cada uso, deslizando a tampa sobre superfície plana;
- Não limpar a agulha com álcool (o álcool remove a lubrificação de silicone, acelerando o embotamento);
- Realizar rodízio rigoroso dos locais de aplicação (abdômen, coxas, glúteos, braços), com distância mínima de 1 cm entre aplicações consecutivas;
- Descartar a seringa imediatamente se a agulha estiver visivelmente torta, se a injeção causar dor significativamente maior que o habitual, ou se a agulha tiver tocado qualquer superfície além da pele;
- Não reutilizar a seringa quando se faz mistura de dois tipos de insulina na mesma seringa;
- Não reutilizar a seringa em casos de imunossupressão, feridas abertas nas mãos ou infecção cutânea ativa.

7. SOBRE OS RISCOS DA PROPAGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INACURADAS POTENCIALMENTE DANOSAS À COMPREENSÃO

DO CONTEXTO PELA POPULAÇÃO

É necessário alertar que a veiculação de informações não alinhadas às evidências e às diretrizes oficiais desta autoridade sanitária acerca da reutilização de seringas — sem respaldo nas evidências científicas e em contradição com o PCDT do próprio Ministério da Saúde — pode gerar consequências graves para a saúde pública. Pessoas com diabetes em uso de insulina que, por medo ou desconfiança,

deixem de aplicar insulina na ausência de uma seringa nova, correm risco imediato e real de descompensação hiperglicêmica, cetoacidose diabética, coma e óbito. Esse risco é incomparavelmente maior do que qualquer risco associado à reutilização limitada da seringa pela mesma pessoa, como demonstram as evidências apresentadas nesta nota.

Além disso, tais abordagens sobre o tema comprometem a confiança dos usuários nas orientações das equipes de saúde, geram estresse e ansiedade em uma população que já convive com a carga diária de uma condição crônica, e podem comprometer a adesão ao tratamento prescrito — fator reconhecidamente determinante para o controle glicêmico e a prevenção de complicações. O vínculo de confiança entre o usuário e sua equipe de saúde é um patrimônio construído ao longo de anos de acompanhamento, e deve ser preservado com responsabilidade por todos os atores envolvidos na comunicação em saúde.

Esta Secretaria reafirma seu compromisso com a transparência e com orientações baseadas nas melhores evidências disponíveis, e permanece à disposição para esclarecimentos técnicos.

8. Referências

1. ABNT. NBR ISO 8537:2012 — Seringas estéreis de uso único, com ou sem agulha, para insulina. / ISO 8537 — Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin.
2. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes — 2025. *Diabetes Care*. 2025;48(Suppl 1):S146–S166. Seção 7: Diabetes Technology.
3. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes — 2026. *Diabetes Care*. 2026;49(Suppl 1):S150–S165. Seção 7: Diabetes Technology.
4. ANVISA. RDC nº 156/2006; RE nº 2.605/2006; RE nº 2.606/2006; RDC nº 3/2011; RDC nº 341/2020.
5. BRASIL. Ministério da Saúde Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Coordenação-Geral de Assistência Farmacêutica Básica. **Ofício Circular Nº 26/2024/CGAFB/DAF/SECTICS/MS** - Informe sobre distribuição e abastecimento de Insulina Humana NPH e regular 100 UI/mL.2024.
6. BRASIL. Ministério da Saúde Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Coordenação-Geral de Assistência Farmacêutica Básica. **Nota Técnica Nº 204/2019-CGAFB/DAF/SCTIE/MS** – Informações sobre distribuição e critérios para dispensação das canetas aplicadoras de insulina humana NPH (Insulina Humana NPH 100 UI/ml, tubete de 3 ml), insulina humana regular (Insulina Humana Regular 100 UI/ml, tubete de 3 ml) e agulhas de aço inoxidável para caneta aplicadora. 2019.
7. BRASIL. Ministério da Saúde Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Coordenação-Geral de Assistência Farmacêutica Básica. **Nota Técnica nº 169/2022** - Atualização sobre distribuição e critérios sugeridos para dispensação das canetas aplicadoras de insulina humana NPH, insulina humana regular e agulhas de aço inoxidável para caneta aplicadora. 2022.
8. Brasil. Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica nº 36 — Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica: Diabetes Mellitus. 2013.
9. Brasil. Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 500/2018 — CGCEAF/DAF/SCTIE/MS.
10. Brasil. Ministério da Saúde. PCDT do Diabetes Mellito Tipo 2. Portaria SCTIE/MS nº 13, de 21 de fevereiro de 2026.
11. Klonoff DC et al. Advance insulin injection technique and education with FITTER Forward expert recommendations. *Mayo Clin Proc*. 2025;100(4). doi:10.1016/j.mayocp.2025.01.004
12. Puder JJ et al. Using insulin pen needles up to five times does not affect needle tip shape nor increase pain intensity. *Diabetes Res Clin Pract*. 2005;67(2):119-123. doi:10.1016/j.diabres.2004.06.001
13. Sociedade Brasileira de Diabetes. Práticas seguras para preparo e aplicação de insulina. Diretriz Oficial da SBD, Ed. 2025. Disponível em: <https://diretriz.diabetes.org.br/praticas-seguras-para-preparo-e-aplicacao-de-insulina/>
14. Zabaleta-Del-Olmo E et al. Safety of the reuse of needles for subcutaneous insulin injection: a systematic review and meta-analysis. *Int J Nurs Stud*. 2016;60:121-132. doi:10.1016/j.ijnurstu.2016.04.010.

Atenciosamente,

JULIANA DIAS CIRILO
Coordenadora das Linhas de Cuidado das Doenças Crônicas Não Transmissíveis
S/SUBPAV/SAP/CDNT
11/322.026-6

LARISSA CRISTINA TERREZO MACHADO
Superintendente de Atenção Primária
S/SUBPAV/SAP
324.362-3

RENATO CONY SERÓDIO
Subsecretário de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde
S/SUBPAV
324.374-8



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DIAS CIRILO, Coordenador II**, em 17/04/2026, às 23:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 26 do [Decreto Rio nº 57.250, de 19 de novembro de 2025](#).



Documento assinado eletronicamente por **LARISSA CRISTINA TERREZO MACHADO, Superintendente**, em 17/04/2026, às 23:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 26 do [Decreto Rio nº 57.250, de 19 de novembro de 2025](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://prefeitura.sei.rio/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0&cv=3409311&crc=C7184B99, informando o código verificador **3409311** e o código CRC **C7184B99**.